DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2025.09.18

·专家共识·

艾滋病中医诊疗专家共识

中华中医药学会防治艾滋病分会

摘要：国家中医药管理局于2015年发布了《国家中医药管理局医政司关于印发泄泻等12个艾滋病常见病症中医诊疗方案（试行）的通知》（简称《12个病症》），于2016年制定了《艾滋病（成人）中医诊疗方案》（简称《方案》），《艾滋病中医诊疗专家共识》（以下简称《共识》）是在《方案》、《12个病症》基础上，参照最新临床和基础研究进展修订编制。《共识》对西医诊断、疗效评价等内容进行更新，并新增推荐证据和推荐强度、方药剂量。《共识》包括诊断标准、中医药治疗、疗效评价等三大方面的内容。本《共识》主要目的是推荐有循证医学证据的艾滋病中医药诊断与治疗方法，指导临床医生、护理人员规范使用中医药进行实践活动。

关键词：艾滋病病毒感染者/艾滋病患者；中医药；诊断；治疗；专家共识

中图分类号：R 512.91；R 246.7 **文献标志码：**A **文章编号：**1672-5662（2025）09-1029-06

Expert consensus on traditional Chinese medicine diagnosis and treatment of AIDS STD/AIDS Prevention and Control Academic Committee, Chinese Association of Traditional Chinese Medicine

Corresponding author: LIU Ying, Email: liuying@cacms.cn

Supported by National Major Science and Technology Special Project for Infectious Disease Prevention and Control (2017ZX10205501); National Natural Science Foundation of China Project (81403271, 82174221); Special Technology Project for Traditional Chinese Medicine Industry (201507005)

Abstract: In 2015, the National Administration of Traditional Chinese Medicine (TCM) issued the *Notice of the Department of Medical Affairs of the National Administration of Traditional Chinese Medicine on Printing and Distributing the Chinese Medicine Diagnosis and Treatment Plan for 12 Common Diseases of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, including Diarrhea (hereinafter referred to as the "12-Disease"). In 2016, the *Chinese Medicine Diagnosis and Treatment Plan for AIDS (Adults)* (hereinafter referred to as the "Plan") was formulated. The *Expert Consensus on Traditional Chinese Medicine Diagnosis and Treatment of AIDS* (referred to as "Consensus") was revised based on the "Plan", the "12-Disease", and the latest clinical and basic research progress. The Consensus updated the contents of Western medicine diagnosis and efficacy evaluation, and added recommended evidence, recommended intensity and prescription dosage. The Consensus encompasses three aspects: diagnostic criteria and TCM treatment, efficacy evaluation. The main purpose of this Consensus is to recommend evidence - based TCM diagnosis and treatment methods for AIDS, and guide clinicians and nurses to standardize the use of TCM for practical activities.

Keywords: HIV/AIDS; traditional Chinese medicine（TCM）; diagnosis; treatment; expert consensus

艾滋病是由HIV引起的一种慢性传染病，其主要病理特征为CD4细胞数量显著降低，造成免疫缺陷状态，继而发生各种机会性感染以及肿瘤，最终导致死亡。截至2024年12月31日，全国31个省（自治区、直辖市）（不含港澳台）报告现存活HIV/AIDS患者1 355 017例，报告死亡491 437例[1]。尽管cART可持续有效地在最大限度上抑制病毒，但部分患者因药物不良反应、耐药性、免疫重建不全等使得艾滋病治疗复杂化。中医药治疗艾滋病在增强患者免疫功能、改善症状、减少某些机会性感染、减轻cART药物某些不良反应、提高患者生活质量方面均取得了较好的效果。近年来，随着中医药防治艾滋病临床实践和科学研究的不断拓展和深化，以及中西医协同治疗艾滋病的发展趋势，中医药防治艾滋病的切入点更加明确，对艾滋病某一病症的研究更加深入，同时也积累了一系列新的临床研究证据。为及时跟踪近年来中医药防治艾滋病领域最新研究成果，更好地指导艾滋病中医临床实践，《艾滋病中医诊疗专家共识》（以下简称《共识》）在2016年《艾滋病（成人）中医诊疗方案》、2015年《国家中医药管理局医政司关于印发泄泻等12个艾滋病常见病症中医诊疗方案（试行）的通知》的基础上参照国内外最新研究

收稿日期：2025-05-07；**修回日期：**2025-08-22

基金项目：传染病防治国家科技重大专项（2017ZX10205501）；国家自然科学基金项目（81403271、82174221）；中医药行业科技专项项目（201507005）

通信作者：刘颖，Email：liuying@cacms.cn

进展修订而成。本《共识》将分散的临床经验转化为可推广的规范，既体现中医辨证精髓，又契合现代循证医学要求。通过系统总结近年来研究成果，以期为中医药在艾滋病防治领域提供了科学化、标准化的实践路径。

本《共识》中的推荐意见基于科学研究证据和专家意见，每条推荐意见后面大写字母（A、B或C）和阿拉伯数字（1或2）分别表示支持该推荐意见的证据质量和推荐强度，见表1[根据推荐等级评估、制订与评价（grading of recommendations assessment, development, and evaluation，GRADE）分级修订]。

表1 推荐意见的证据分级与推荐强度分级标准

分级	具体描述
证据级别	
A（高质量）	进一步研究不大可能改变对该评估结果的信心
B（中等质量）	进一步研究有可能使我们对该评估结果的信心产生重要影响
C（低质量）	进一步研究很有可能影响该评估结果，且该评估结果很可能改变
推荐等级	
1（强推荐）	充分考虑到了证据的质量，患者可能的预防、诊断和治疗成本而最终得出的推荐意见
2（弱推荐）	证据价值参差不齐，推荐意见存在不确定性，或推荐的意见可能会有较差的成本疗效比等，更倾向于较低等级的推荐

中医理论在艾滋病治疗中提供了独特的视角和指导原则，其核心在于“整体观念、辨证论治”，将艾滋病视为一种“疫病”，并伴随严重的脏腑虚损，最终导致“虚劳”。古籍虽无“艾滋病”之名，但其对“疫病”、“虚劳”等病机的深刻论述为现代中医认识和治疗艾滋病提供了宝贵的理论基础和思路。《素问·刺法论》曰：“五疫之至，皆相染易，无问大小，病状相似。”强调了疫病的传染性和普遍性。《素问·评热病论》：“邪之所凑，其气必虚。”强调了正气亏虚是外邪入侵发病的内在关键因素。《素问·刺法论》：“正气存内，邪不可干。”从正面强调了正气充足对抵御外邪的重要性，是中医防治疫病的核心思想。《理虚元鉴》：“治虚有三本，肺脾肾是也。肺为五脏之天，脾为百骸之母，肾为性命之根。”精辟地概括了虚劳治疗的核心在于调补肺、脾、肾三脏。这与艾滋病后期以脏腑功能虚损为主的临床表现高度契合。

感染HIV初期，疫毒侵犯。无症状期，疫毒壅遏气机、津血失布，痰浊瘀血互结，正邪相持。进入AIDS期，随着疫毒对精气血的暗耗，肺脾肾等脏腑功能失调，正邪斗争贯穿了艾滋病发生发展变化的全过程[2]，证候多由实证向虚实夹杂证、虚证发展[3]。

根据病原学、临床表现、预后转归等特征，可将艾滋病归属中医“疫病”“虚劳”等范畴，多由疫毒侵袭、耗伤正气、日久全身气血阴阳失调、脏腑功能受损而发病，中医临床采用病证结合治疗可以改善症状、延缓发病及协同增效等[3]。

1 艾滋病诊断标准

1.1 西医诊断 HIV感染是一个较为漫长、复杂的过程，根据感染后的临床表现，HIV感染的全过程可分三期，即急性期、无症状期和AIDS期[4]。

参照《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断》（WS293-2019）[5]、《中国艾滋病诊疗指南（2024版）》[4]。

成人、青少年及18月龄以上儿童，符合下列一项者即可诊断HIV感染：①HIV抗体筛查试验阳性和HIV补充试验阳性（抗体补充试验阳性或核酸定性检测阳性或核酸定量>1 000拷贝/mL）；②有流行病学史或AIDS相关临床表现，2次HIV核酸检测均为阳性；③HIV分离试验阳性。

18月龄及以下儿童，符合下列一项者即可诊断HIV感染：①为HIV感染母亲所生和2次HIV核酸检测均为阳性（第二次检测需在出生4周后采样进行）；②有医源性暴露史，HIV分离试验结果阳性或2次HIV核酸检测均为阳性；③为HIV感染母亲所生和HIV分离试验阳性。

1.2 中医证候诊断 HIV侵袭人体后，正邪交争，元气渐亏，气血阴阳日损，最终导致脾肾阳虚、阳损及阴、阴阳离绝[3]。证候演变多由实证向虚实夹杂证、虚证发展，其中HIV感染者以肺脾两虚证为主，AIDS患者以脾肾阳虚证为主。性传播者以肝郁气滞、阴虚内热、脾肾阳虚为主。静脉吸毒者以热毒内蕴、气虚血瘀、气阴两虚为主。有偿供血者以肺脾两虚、脾肾阳虚为主。临床常见证候如下：

1.2.1 *热毒内蕴证* 发热，体温38 ℃左右，皮肤红疹或斑块或疱疹（疼痛剧烈，面积大，反复难愈），或口疮（多发、易复发、面积大，缠绵难愈），或有脓疱，或躯干四肢有疖肿，或疮疡，伴红肿热痛，或咳嗽痰黄，口苦口臭。舌质红或绛，苔黄腻，脉滑数。

1.2.2 *肝郁气滞证* 胸胁胀满，善太息，情志抑郁，急躁易怒，失眠多梦，口苦咽干，全身淋巴结肿大（一般大于1 cm，多发于耳前、耳后、下颌、腋下、腹股沟等处）；妇女月经不调，乳房胀痛，少腹结块。舌苔薄白，脉弦。

1.2.3 *气虚血瘀证* 面色萎黄或黯黑，乏力、气短，躯干或四肢有固定痛处或肿块，午后或夜间发热，遇

劳复发或加重，自汗，易感冒，食少便溏，或脱发。舌暗红，或有瘀点瘀斑，脉沉涩。

1.2.4 阴虚内热证 两颧发红，形体消瘦，午后潮热，或夜间发热，失眠盗汗，五心烦热，咳嗽，久嗽，乏力、气短，口燥咽干，大便干结，小便黄赤。舌红少苔，脉细数。

1.2.5 肺脾两虚证 声低懒言，神疲乏力，久咳不止，气短而喘，咯痰清稀，面白无华，食欲不振，食少，腹胀，便溏，以慢性腹泻多见，次数多于3次/日，持续时间长，抗生素治疗效果不明显。舌淡，苔白滑，脉弱。

1.2.6 气阴两虚证 少气，懒言，神疲，乏力，自汗，盗汗，动则加剧，易感冒，或伴口干舌燥，五心烦热，形体消瘦，体重减轻，或见干咳少痰。舌体瘦薄，舌质淡，苔少，脉虚细数无力。

1.2.7 脾肾阳虚证 面色㿠白，畏寒肢冷，腰膝酸软，腹中冷痛，或腹胀肠鸣，腹泻剧烈或五更泄泻，下利清谷，或小便不利，或面浮肢肿，或见小便频数，余沥不尽。舌质淡胖有齿痕，苔白滑，脉沉迟细弱。

2 治疗

2.1 辨证治疗

2.1.1 热毒内蕴证

1）治法：清热解毒。

2）推荐方药：黄连解毒汤合升降散加减[6]。药物组成：黄连5 g、黄芩5 g、黄柏5 g、栀子10 g、僵蚕6 g、蝉蜕6 g、姜黄6 g、大黄5 g、荆芥10 g、防风10 g、牛蒡子9 g、金银花12 g、大青叶9 g、板蓝根12 g、牡丹皮12 g、桔梗9 g、薄荷6 g、炙甘草6 g。口疮者，加法半夏6 g、生姜9 g、黄连5 g、细辛3 g等；咳痰黄稠者，加芦根15 g、冬瓜仁12 g、前胡10 g、鱼腥草15 g等；疮疡者，加土茯苓15 g、滑石15 g、苦参6 g等。每日1剂，水煎取汁400 mL，分2次服用，早晚各1次。连续服用≤6个月，停药2周评估疗效。（证据级别B；推荐等级2）。

3）推荐中成药：唐草片[7]、青蒿琥酯片[8-10]。唐草片用法用量：口服，一次8片，一日3次，连续服用≤6个月，停药2周评估疗效。青蒿琥酯片用法用量：口服，一次50 mg，一日2次，连续服用≤6个月，停药2周评估疗效。（证据级别A；推荐等级1）

2.1.2 肝郁气滞证

1）治法：疏肝理气。

2）推荐方药：柴胡疏肝散加减[11]。药物组成：柴胡9 g、白芍12 g、陈皮12 g、川芎9 g、香附12 g、枳壳10 g、炙甘草6 g。泛酸者，加吴茱萸5 g、黄连5 g、煅瓦楞子12 g等；呕恶者，加法半夏6 g、生姜6 g、乌梅12 g等；善太息者，加瓜蒌12 g、乌药12 g、厚朴6 g等；乳房胀痛、少腹结块、全身淋巴结肿大者，加龙骨30 g、牡蛎30 g、海藻12 g、昆布12 g等；咽干口苦者，加黄芩5 g、栀子10 g、龙胆草9 g等。每日1剂，水煎取汁400 mL，分2次服用，早晚各1次。连续服用≤6个月，停药2周评估疗效。（证据级别B；推荐等级1）。

3）推荐中成药：加味逍遥丸[12]。用法用量：口服，一次1丸，一日2次。连续服用≤6个月，停药2周评估疗效。（证据级别B；推荐等级1）。

2.1.3 气虚血瘀证

1）治法：益气活血。

2）推荐方药：补中益气汤合血府逐瘀汤加减[13]。药物组成：黄芪15 g、人参9 g、白术12 g、当归12 g、陈皮12 g、柴胡9 g、升麻9 g、桃仁9 g、红花9 g、生地12 g、川芎9 g、赤芍12 g、牛膝12 g、桔梗9 g、枳壳9 g、甘草6 g。胸胁疼痛者，加川楝子9 g、延胡索9 g、蒲黄9 g、血竭2 g等；四肢、躯干肿块者，加王不留行9 g、地龙9 g等。每日1剂，水煎取汁400 mL，分2次服用，早晚各1次。连续服用≤6个月，停药2周评估疗效。（证据级别B；推荐等级1）。

3）推荐中成药：补中益气丸、血府逐瘀丸等[14]。补中益气丸用法用量：口服，一次1袋，一日2次。连续服用≤6个月，停药2周评估疗效。血府逐瘀丸用法用量：口服，一次1袋，一日2次。连续服用≤6个月，停药2周评估疗效。（证据级别B；推荐等级1）

2.1.4 阴虚内热证

1）治法：养阴清热。

2）推荐方药：百合固金汤合六味地黄丸加减[15]。药物组成：百合12 g、熟地12 g、生地12 g、麦冬15 g、玄参9 g、当归12 g、白芍12 g、桔梗9 g、贝母9 g、山萸肉12 g、山药15 g、泽泻9 g、牡丹皮12 g、茯苓12 g、甘草6 g。症状较重者，酌加青蒿12 g、鳖甲12 g、石斛12 g、银柴胡9 g、白薇9 g、地骨皮12 g等。每日1剂，水煎取汁400 mL，分2次服用，早晚各1次。连续服用≤6个月，停药2周评估疗效。（证据级别B；推荐等级1）

3）推荐中成药：养阴清肺丸、麦味地黄丸、青蒿鳖甲片等[15]。养阴清肺丸用法用量：口服，一次6克，一日2次。连续服用≤6个月，停药2周评估疗效。麦味地黄丸用法用量：口服，一次6克，一日2次。连续服用≤6个月，停药2周评估疗效。青蒿鳖甲片用法用量：口服，一次4片，一日3次。连续服用≤6个月，停药2周评估疗效。（证据级别B；推荐等级2）

2.1.5 肺脾两虚证

1)治法:益肺健脾。

2)推荐方药:参苓白术散加减[16-17]。药物组成:人参9 g、茯苓12 g、炒白术15 g、山药15 g、莲子肉12 g、白扁豆15 g、薏苡仁15 g、砂仁6 g、桔梗9 g、炙甘草6 g。面部虚浮、下肢浮肿者,加黄芪15 g、防己9 g等;腹泻者,加诃子9 g、乌梅12 g等;咳嗽者,加法半夏6 g、橘红12 g、前胡10 g等。每日1剂,水煎取汁400 mL,分2次服用,早晚各1次。连续服用≤6个月,停药2周评估疗效。(证据级别B;推荐等级1)。

3)推荐中成药:参苓白术丸[16-17]、益艾康胶囊[18]、参灵固本颗粒[19-21]。参苓白术丸用法用量:口服,一次6克,一日3次。连续服用≤6个月,停药2周评估疗效。益艾康胶囊用法用量:口服,一次5粒,一日3次。连续服用≤6个月,停药2周评估疗效。参灵固本颗粒用法用量:口服,一次6克,一日3次。连续服用≤6个月,停药2周评估疗效。(证据级别B;推荐等级1)

2.1.6 气阴两虚证

1)治法:益气养阴。

2)推荐方药:参芪地黄汤加减[22]。药物组成:人参9 g、黄芪15 g、生地12 g、山药15 g、山萸肉12 g、茯苓12 g、泽泻9 g、牡丹皮12 g、五味子12 g、天花粉12 g、沙参12 g、麦冬15 g、甘草6 g。口干舌燥、五心烦热者,加青蒿12 g、鳖甲12 g、知母6 g等;干咳少痰者,加贝母9 g、紫苑12 g、款冬花12 g等;腰膝酸软者,加牛膝12 g、杜仲12 g等。每日1剂,水煎取汁400 mL,分2次服用,早晚各1次。连续服用≤6个月,停药2周评估疗效。(证据级别B;推荐等级1)

3)推荐中成药:六味地黄丸[15]、扶正抗毒丸[23]、太芪培元颗粒[24]、免疫2号颗粒[25-27]。六味地黄丸用法用量:口服,一次6克,一日2次。连续服用≤6个月,停药2周评估疗效。扶正抗毒丸用法用量:口服,一次1袋,一日4次。疗程2年。太芪培元颗粒用法用量:口服,一次1袋,一日3次。连续服用≤6个月,停药2周评估疗效。免疫2号颗粒用法用量:口服,一次1袋,一日2次。连续服用≤6个月,停药2周评估疗效。(证据级别B;推荐等级1)

2.1.7 脾肾阳虚证

1)治法:温补脾肾。

2)推荐方药:真武汤合附子理中汤加减[28]。药物组成:附子9 g、茯苓12 g、白芍12 g、白术12 g、干姜6 g、人参9 g、肉桂3 g、淫羊藿12 g、鹿角胶3 g、阿胶9 g。五更泄者,加补骨脂12 g、菟丝子12 g、肉豆蔻12 g等;小便频数者,加益智仁12 g、乌药12 g等。每日1剂,水煎取汁400 mL,分2次服用,早晚各1次。连续服用≤6个月,停药2周评估疗效。(证据级别B;推荐等级2)

3)推荐中成药:金匮肾气丸[29]、温肾健脾颗粒[30-32]。金匮肾气丸用法用量:口服,一次6克,一日2次。连续服用≤6个月,停药2周评估疗效。温肾健脾颗粒用法用量:口服,一次1袋,一日2次。连续服用≤6个月,停药2周评估疗效。(证据级别B;推荐等级1)

2.2 中成药治疗 唐草片[7,,33-34](证据级别A;推荐等级1)

1)适应证:用于HIV/AIDS患者(CD4细胞在100~400个/mm^{3}之间),表现为乏力,脱发、食欲减退和腹泻等气虚血瘀、热毒侵袭证候的感染者。

2)成分:老鹳草、金银花、瓜蒌皮、柴胡、香薷、黄芪、甘草、木棉花、鸡血藤、糯稻根、龙葵、白花蛇舌草等。

3)功能主治:清热解毒,益气活血。

4)用法用量:cART基础上加用唐草片,口服,每日3次,每次8片(0.4 g/片)。于服用cART药品后1 h温开水送服,连续服用≤6个月,停药2周评估疗效。

5)注意事项:①急性感染期、严重的机会性感染、机会性肿瘤、过敏体质、严重的精神及神经疾病的患者服用应遵医嘱。②尚未进行对儿童、老年患者、孕期及哺乳期妇女的临床研究,因此上述人群慎用。

2.3 艾灸治疗

中医针灸疗法中的艾灸疗法,是点燃用艾叶制成的艾炷、艾条,熏烤人体的穴位以达到保健治病的一种自然疗法。它具有疏通经络、温经散寒、扶阳固脱、升阳举陷、拔毒泄热、防病保健、延年益寿及调节免疫的作用。以下证型可根据临床实际采用艾灸治疗。

2.3.1 肺脾两虚证 取穴:太渊、肺俞,关元、脾俞、肾俞、神阙、气海,交替选用[35]。(证据级别B;推荐等级1)

操作方法:点燃艾条,距离穴位2~3 cm,灸至皮肤潮红为度;每次20-30 min,每日1次,10天为1疗程,连续2~3个疗程。

2.3.2 气阴两虚证 取穴:肺俞、膻中、太溪,命门、肾俞、足三里、涌泉,交替选用[36]。(证据级别B;推荐等级1)

操作方法:点燃艾条,距离穴位2~3 cm,灸至皮

肤潮红为度；每次20-30 min，每日1次，10天为1疗程，连续2~3个疗程。。

2.3.3 脾肾阳虚证 取穴：关元、气海、足三里、三阴交，内关、百会、膈俞、脾俞、肾俞，交替选用[37]。（证据级别B；推荐等级1）

操作方法：点燃艾条，距离穴位2~3 cm，灸至皮肤潮红为度；每次20-30 min，每日1次，20天为1疗程，连续2~3个疗程。

3 疗效评价

3.1 生物学指标评价

3.1.1 CD4细胞计数 观察CD4细胞计数在一定时间内的变化情况。

检测方法：每半年检测一次，比较CD4细胞计数在不同时间的变化情况。

评价标准：

有效：治疗半年后，CD4细胞计数上升≥30%或50个/mm^3；

无效：治疗半年后，CD4细胞计数上升<30%或50个/mm^3。

3.1.2 病毒载量 观察血浆中病毒载量水平在一定时间内的变化情况。

检测方法：每半年检测一次，比较不同时间患者血浆中病毒载量水平的变化情况。

评价标准：

有效：治疗半年后，血浆病毒载量水平下降，拷贝数降低≥1 log拷贝/mL；

无效：治疗半年后，血浆中病毒载量水平持续上升，或拷贝数下降<1 log拷贝/mL。

3.2 HIV/AIDS患者报告结局和生存质量评价

3.2.1 《HIV/AIDS患者报告结局评价量表》（简称《HIV/AIDS PRO量表》）评价 观察患者一定时间内的病情变化情况。

测评方法：每3个月或半年测评一次，比较不同时间患者自我感受的变化情况。

评价标准：《HIV/AIDS PRO量表》分为躯体状况、生活状况、总体评价等3个部分，计算治疗前后各部分积分情况，经t检验，P<0.05或P<0.01为有效，P≥0.05为无效。

3.2.2 《世界卫生组织艾滋病患者生存质量量表（中国版）》（简称《生存质量量表》）评价 观察患者一定时间内的生活质量情况。

测评方法：每3个月或半年测评一次，比较不同时间患者对生活状态满意度的变化情况。

评价标准：《生存质量量表》分为生理、心理、独立性、环境、社会关系、精神支柱/宗教/个人信仰等6个部分，计算治疗前后各部分积分情况，经t检验，P<0.05或P<0.01为有效，P≥0.05为无效。

当前共识存在三方面不足：其一，部分推荐（如青蒿琥酯片）证据源于小样本研究，需开展多中心大样本RCT验证长期疗效；其二，未纳入地域气候差异（如南方湿热证高发）的辨证调整方案；其三，特殊人群（儿童、孕妇）用药缺乏指导。亟待通过地域化方案设计及特殊人群研究填补空白。

综上，《艾滋病中医诊疗专家共识》在推动中医规范化诊疗方面发挥了重要作用，《共识》对西医诊断、疗效评价等内容进行更新，并新增推荐证据和推荐强度、方药剂量。《共识》包括流行病学、诊断标准、中医药治疗、疗效评价等四大方面的内容。本《共识》旨在推荐有循证医学证据的艾滋病中医药诊断与治疗方法，指导临床医生、护理人员规范使用中医药进行实践活动，今后通过多学科协作，针对本共识不足之处，开展深入的研究探索，将中医“整体调节”优势转化为可量化的临床实践方案。

执笔人：梁碧颜（中国中医科学院）

编写组专家：王健（中国中医科学院）、邹雯（中国中医科学院）、董继鹏（中国中医科学院）、周俊（中国中医科学院）、郭会军（河南中医药大学第一附属医院）、汪宁（中国疾病预防控制中心）、徐立然（河南中医药大学第一附属医院）、喻剑华（杭州市西溪医院）、李鑫（首都医科大学附属北京地坛医院）、马萍（天津医科大学附属第二人民医院）、王俊杰（中国疾病预防控制中心）、李秀惠（首都医科大学附属北京佑安医院）、胡建华（首都医科大学附属北京佑安医院）、李伟华（首都医科大学附属北京佑安医院）、张伟（首都医科大学附属北京地坛医院）、王憋杰（中国医学科学院肿瘤医院）、姜枫（广西中医药大学附属瑞康医院）、王军文（湖南中医药大学第二附属医院）、扈晓宇（成都中医药大学附属医院）、张国梁（安徽省中医院）、王莉（云南省中医中药研究院）、毛宇湘（河北省中医院）、邓鑫（广西中医药大学）、谭行华（广州医科大学附属市八医院）、林路平（广州医科大学附属市八医院）、马建萍（新疆维吾尔自治区中医医院）、刘振威（广西中医药大学附属瑞康医院）、陈耀凯（重庆市公共卫生医疗救治中心）、冯全生（成都中医药大学）、杨毅（湖北省中医院）、舒占钧（新疆维吾尔自治区中医医院）、马丽琴（临汾市第三人民医院）、靳娟（西安市第八医院）、辛晓丽（沈阳市第六人民医院）、苏琛（四川省中医药科学院）、许前磊（河南中医药大学第一附属医院）、高丽英（天津医科大学附属第二人民医院）、陈昕（昆明市中医医院）、魏洪霞（南京中医药大学附属南京医院）、赵鹏飞（青海省第四人民医院）、牟方政（重庆大学附属三峡医院）、李鹏宇（河南中医药大学第一附属医院）、李白雪（成都中医药大学）、文莉（成都中医药大学）、于爱平（天津医科大

学附属第二人民医院）、杨玉琪（云南省中医中药研究院）、孙俊（云南省中医中药研究院）、蒲亚萍（云南省中医中药研究院）、陆中云（云南省中医中药研究院）、夏海梅（云南省中医中药研究院）、罗威（长春中医药大学附属医院）、陈一（贵阳市公共卫生救治中心）、杨国强（重庆市公共卫生医疗救治中心）。

致谢 衷心感谢所有参与制定这份共识的专家和机构，你们的专业知识和努力为本共识的出版做出了巨大的贡献。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突。

参考文献：

[1] 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心.2024年12月全国艾滋病性病疫情[J].中国艾滋病性病，2025，31(3)：225.DOI：10.13419/j.cnki.aids.2025.03.01.

[2] 钟妮，李钢磊，王志威，等.艾滋病中医证候病机学研究进展[J].时珍国医国药，2018，29(1)：167-169. DOI：10.3969/j.issn.1008-0805.2018.01.059.

[3] 国家中医药管理局办公室，国家卫生计生委办公厅.国家中医药管理局办公室国家卫生计生委办公厅关于印发艾滋病（成人）中医诊疗方案的通知[EB/OL].(2016-04-28)[2025-04-22]. http://www. natcm. gov. cn/yizhengsi/zhengcewenjian/2018-03-24/3159.html.

[4] 中华医学会感染病学分会艾滋病学组，中国疾病预防控制中心.中国艾滋病诊疗指南（2024版）[J].中国艾滋病性病，2024，30(8)：779-806.DOI：10.13419/j.cnki.aids.2024.08.01.

[5] 国家卫生健康委员会.艾滋病和艾滋病病毒感染诊断WS 293—2019[EB/OL].(2024-09-30)[2025-04-22]. http://www.nhc.gov. cn/wjw/s9491/201905/6430aa653728439c901a7340796e4723/files/84 dffca4fb2c4293abb6be4 d5353f924.pdf.

[6] 谢世平，郭会军，王健.艾滋病中医诊疗指南（2013版）[J].中医学报，2014，29(5)：617-620. DOI：10.16368/j. issn. 1674-8999.2014.05.003.

[7] 宋业兵，龙海，符燕华，等.唐草片对艾滋病免疫功能重建不良患者的疗效观察[J].中国皮肤性病学杂志，2024，38(3)：298-302. DOI：10.13735/j.cjdv.1001-7089.202304102.

[8] 董继鹏，陶庄，郭会军，等.青蒿琥酯用于艾滋病抗反转录病毒疗法后免疫功能重建不全的疗效特点[J].中华中医药杂志，2022，37(7)：4170-4175.

[9] 陶庄，董继鹏，郭会军，等.青蒿琥酯片对HIV/AIDS患者ART后免疫功能重建不全影响的研究[J].中国艾滋病性病，2021，27(9)：921-925. DOI：10.13419/j.cnki.aids.2021.09.03.

[10] 许琪华，吴雪，郑海鹏，等.青蒿琥酯对HAART后免疫重建不良HIV/AIDS患者免疫功能和肠道菌群影响的研究[J].中医药学报，2022，50(12)：54-59.DOI：10.19664/j.cnki.1002-2392.220274.

[11] 中华中医药学会防治艾滋病分会.艾滋病相关焦虑中西医协同治疗专家共识[J].中医学报，2020，35(9)：1889-1892. DOI：10.16368/j.issn.1674-8999.2020.09.423.

[12] 陆中云，佴旭，王莉，等.逍遥散合二陈汤治疗人类免疫缺陷病毒感染/艾滋病血脂异常的临床研究[J].时珍国医国药，2021，32(4)：903-904. DOI：10.3969/j. issn. 1008-0805.2021.04.37.

[13] 杨玲，范小会.补中益气汤联合西医疗法治疗脾气虚弱型艾滋病17例[J].中医研究，2018，31(11)：32-33. DOI：10.3969/j.issn.1001-6910.2018.11.12.

[14] 张耀.补中益气汤辅助治疗艾滋病的效果观察[J].当代医药论丛，2019，17(12)：79-80.

[15] 姜枫，张荣欣，张亚萍，等.190例老年艾滋病患者中医证候及用药特点分析[J].中医杂志，2016，57(1)：51-54. DOI：10.13288/j.11-2166/r.2016.01.013.

[16] 周淑娟，王延丽，原海珍，等.参苓白术散联合抗逆转录病毒治疗干预对免疫重建不良肺脾气虚证HIV/AIDS患者疗效评价[J].医药论坛杂志，2024，45(8)：811-815. DOI：10.20159/j.cnki.jmf.2024.08.006.

[17] 孟宗德，刘启明，马永强，等.中医辨证论治艾滋病相关呕吐的临床疗效及对呕吐症状积分的影响[J].中医研究，2021，34(10)：14-17. DOI：10.3969/j.issn.1001-6910.2021.10.05.

[18] 陈昭云，孙燕，张雪，等.抗病毒治疗联合益艾康胶囊对HIV/AIDS患者免疫功能重建的影响[J].中国艾滋病性病，2022，28(10)：1132-1135.DOI：10.13419/j.cnki.aids.2022.10.04.

[19] 柯佳宁，高文波，刘颖.参灵固本颗粒对艾滋病免疫重建不全患者生存质量和免疫功能的影响[J/OL].中国实验方剂学杂志，1-11. DOI：10.13422/j.cnki.syfjx.20250991.

[20] 马冲.基于数据挖掘探讨中医药治疗HIV/AIDS免疫无应答的用药规律及参灵固本方的临床研究[D].中国中医科学院，2023.DOI：10.27658/d.cnki.gzzyy.2023.000026.

[21] 吴雪.中医药调控肠道菌群改善艾滋病免疫重建不全作用的临床观察[D].北京：中国中医科学院，2021. DOI：10.27658/d.cnki.gzzyy.2021.000109.

[22] 郭永琳，朱振华，张瑞卿.参芪地黄汤加减方联合抗病毒药物治疗艾滋病的临床研究[J].养生保健指南，2018(36)：70. DOI：10.3969/j.issn.1006-6845.2018.36.067.

[23] 张贵玉.扶正抗毒丸辅助高效抗反转录病毒疗法对艾滋病临床症状及免疫状态的干预作用[J].河南医学研究，2020，29(27)：5125-5127. DOI：10.3969/j.issn.1004-437X.2020.27.056.

[24] 刘旭辉，陈媛媛，侯明杰，等.太芪培元颗粒联合HAART对HIV/AIDS患者免疫重建的影响[J].亚太传统医药，2020，16(5)：108-111. DOI：10.11954/ytctyy.202005038.

[25] 刘颖，王健，邹雯，等.免疫2号颗粒对HAART后免疫重建不全艾滋病患者CD4+淋巴细胞计数的影响[J].中医杂志，2017，58(1)：34-37.DOI：10.13288/j.11-2166/r.2017.01.010.

[26] 邹雯，王健，刘颖，等.中药联合高效抗逆转录病毒疗法对艾滋病免疫重建不全患者IL-2及IL-10 mRNA水平的影响[J].中国中医基础医学杂志，2017，23(6)：824-825，836. DOI：10.19945/j.cnki.issn.1006-3250.2017.06.029.

[27] 邹雯，王健，刘颖，等.中药联合HAART治疗对艾滋病免疫功能重建不全患者TLR相关基因mRNA水平的影响[J].中华中医药杂志，2017，32(12)：5672-5674.

[28] 赵正阳，徐立然，李春燕，等.经方治疗艾滋病腹泻[J].中医研究，2017，30(6)：60-64. DOI：10.3969/j. issn. 1001-6910.2017.06.25.

[29] 中华中医药学会防治艾滋病分会.艾滋病免疫功能重建不良中西医协同治疗专家共识[J].中医学报，2020，35(2)：281-284. DOI：10.16368/j.issn.1674-8999.2020.02.064.

[30] 邹雯，陈昕，李永红，等.温肾健脾法对高效抗转录病毒疗法后免疫重建不全艾滋病患者异常免疫激活的影响[J].中华中医药杂志，2025，40(1)：447-450.

[31] 咸庆飞，刘颖，邹雯，等.温肾健脾颗粒对HAART后免疫重建不全艾滋病患者T淋巴细胞亚群的作用研究[J].中国中医基础医学杂志，2019，25(10)：1391-1392，1455. DOI：10.19945/j.cnki.issn.1006-3250.2019.10.023.

[32] 邹雯.基于细胞免疫激活及Treg途径探讨温肾健脾方对艾滋病HAART后免疫无应答患者的影响[D].北京：中国中医科学院，2019.

[33] 许琪华，陈思言，林路平，等.唐草片治疗19例艾滋病合并代偿期肝硬化患者的临床观察[J].中西医结合肝病杂志，2023，33(8)：702-704，709. DOI：10.3969/j. issn. 1005-0264.2023.008.006.

[34] 何清辉，黄惠玲，罗美菊.唐草片联合胸腺肽肠溶片对艾滋病高效抗反转录病毒治疗中免疫重建不良的应用效果[J].中外医学研究，2023，21(22)：41-44. DOI：10.14033/j.cnki.cfmr.2023.22.011.

[35] 敖雯，陈雅红，陈玮，等.艾灸联合抗病毒方案治疗艾滋病35例[J].福建中医药，2024，55(5)：59-60，63. DOI：10.13260/j.cnki.jfjtcm.2024.05016.

[36] 赵玲.中药联合艾灸治疗艾滋病腹泻的临床有效性研究[J].中外女性健康研究，2023(11)：34-35，53.

[37] 李静茹，马建萍，马秀兰，等.艾灸治疗脾胃虚弱型艾滋病腹泻临床观察[J].世界科学技术-中医药现代化，2016，18(2)：237-240. DOI：10.11842/wst.2016.02.015.